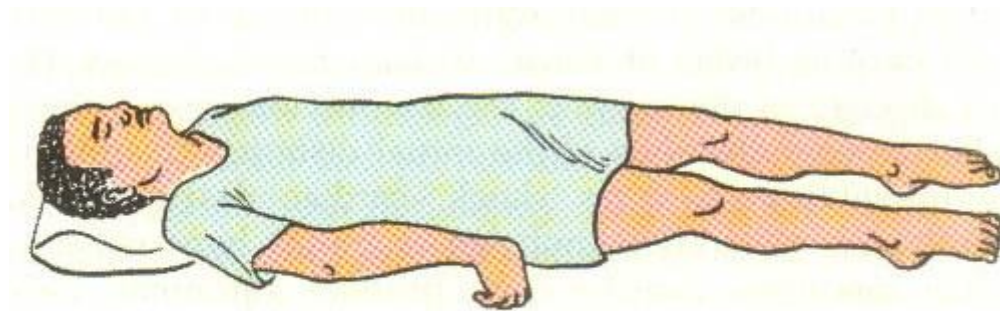


UIDC : Mme Thom

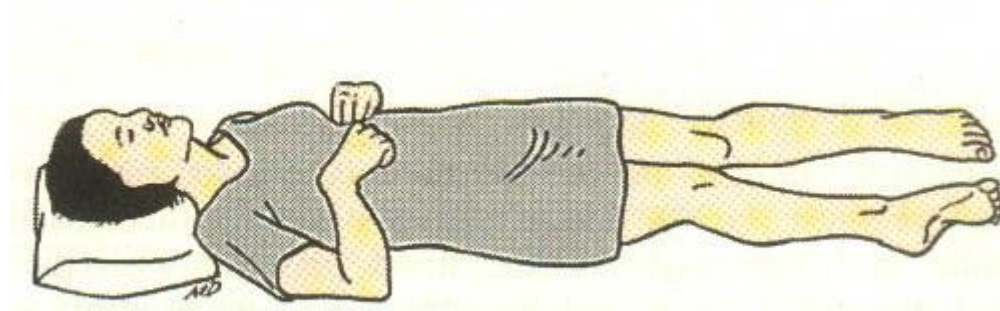
Prof. Adrian Guggisberg
Service de Neuroréducation
adrian.guggisberg@hcuge.ch

Echelle de Glasgow

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
1 - nulle	1 - nulle	1 - nulle
2 - à la douleur	2 - incompréhensible	2 - Extension stéréotypée (rigidité décérébrée)
3 - à la demande	3 - inappropriée	3 - flexion stéréotypée (rigidité de décortication)
4 - spontanée	4 - confuse	4 - évitement
	5 - normale	5 - orientée
		6 - aux ordres



A. Extension posturing (decerebrate rigidity)



B. Abnormal flexion (decorticate rigidity)

Délire = état confusionnel aiguë : DD

Vasculaire

- Hémorragie intra-parenchymateuse, épidural, sous-arachnoïdienne, sous-durale
- AVC
- Thrombose veineuse cérébrale
- Ictus amnésique

Inflammation

- Encéphalite
- Méningite
- Extracérébrale
- Fièvre

Toxique

- Alcool : intoxication ou sevrage
- Drogues
- Médicaments : anticholinergiques, dopaminergiques, antidépresseurs tricycliques, antibiotiques, statines, ...

Métabolique

- Déshydratation
- Perturbation électrolytes
- Hypo-/Hyperglycémie
- Encéphalopathie métabolique (hépatique)
- Encéphalopathie de Wernicke
- Insuffisance rénale
- Hyperthyroïose

Examen neurologique chez le patient comateux ou confus

Paramètres vitaux

- Respiration, TA, P, T, Saturation O2

Réaction à la stimulation externe

- Appel, bruit
- douleurs
- GCS

Nerfs crâniens

- Pupilles : isocorie, réaction à la lumière
- Position des yeux : déviation conjugquée ?
- Nystagmus
- Reflexe vestibulo-oculaire
- Reflexe cornéen
- Reflexe nauséeux

Nuque

- Méningisme

Voies longues

- Tonus
- Mouvements spontanés
- Reflexes ostéotendineux
- Reflexes cutanés

Traumatisme crânio-cérébral (TCC)

Commotion

Définition : TCC sans lésion macroscopique du cerveau

Clinique :

- Perte de conscience courte (si >1h → contusion)
- Etat confusionnel post-traumatique court (si >24h → contusion)
- Amnésie surtout antérograde
- Céphalées diffus
- Vertiges non-directionnel
- Nausées, vomissement
- Troubles de concentration et de mémoire

Thérapie :

- repos max qq jours, puis reprise progressive
- surveillance neurologique

Contusion

Définition : TCC avec lésion de la substance cérébrale

Clinique :

- Perte de conscience courte ou prolongé
- Etat confusionnel souvent prolongé
- Déficits neurologiques

Complications

- Hémorragie
 - o intra-parenchymateuse
 - o sous-durale
 - aiguë
 - chronique
 - o épidurale
 - o sous-arachnoïdienne
- Crises épileptiques ou épilepsie post-traumatiques
- Encéphalopathie post-traumatique avec :
 - o Parésie, syndrome pyramidal
 - o Troubles neuropsychologiques : attention, orientation, fonctions exécutifs, mémoire, héminégligence, aphasie, agressivité, état confusionnel chronique

Causes dangereuses de céphalées aiguës

Hémorragie épidurale

Etiologie

- Presque toujours traumatique
- Rupture de l'artère méningée moyenne (85%) d'autres artères dures, ou rarement saignement veineux

Clinique

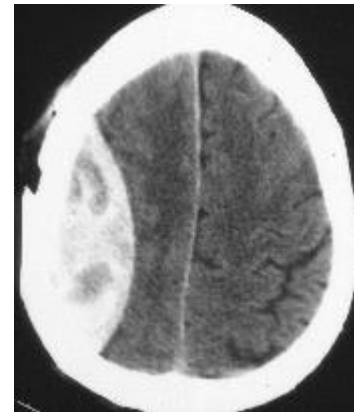
- Traumatisme crânio-cérébral, même léger ! avec ou sans perte de conscience
- Dans 20% des cas intervalle libre, puis nouvelle péjoration rapide de la vigilance
- Dans 60% des cas pas d'intervalle libre !
- Céphalées
- Signes neurologiques focaux
- Signes d'engagement
- Crises épileptiques

Diagnostic

- CT cérébral : hématome en forme de faucille entre dure-mère et l'os crânien

Thérapie

- Urgence absolu
- Craniotomie décompressive



Hémorragie sous-dural aiguë

Etiologie

- Traumatisme avec lésion de veines corticales, rarement des artères

Clinique

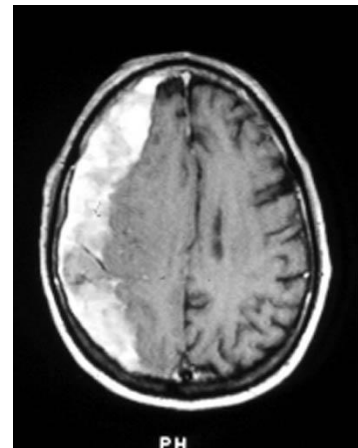
- Troubles de vigilance progressives
- Signes neurologiques focaux
- Signes d'engagement
- Crises épileptiques

Diagnostic

- CT cérébral

Thérapie

- Craniotomie décompressive



Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)

Etiologie

- Faiblesse de paroi d'un vaisseau intracrânien → formation d'anévrisme → rupture → hémorragie dans l'espace sous-arachnoïdien
- Traumatique
- Malformation artério-veineuse
- Dissection artérielle intradurale
- Artérite auto-immune ou infectieuse
- Idiopathique, probablement source veineuse

Epidémiologie

- Prévalence anévrisme intracrânien non-rupturé : ~2% !
- Incidence HSA : ~ 10 / 100'000

Facteurs de risque

- Tabac, OH, HTA, anamnèse familiale

Clinique

- Céphalées à coup de tonnerre, mais aussi apparition sur minutes possible
- Ménigisme à cause de l'irritation par le sang
- Ev. troubles de vigilance, mais pas obligatoire
- Ev. crise épileptique, mais pas obligatoire
- Ev. nausées, vomissements

Complications

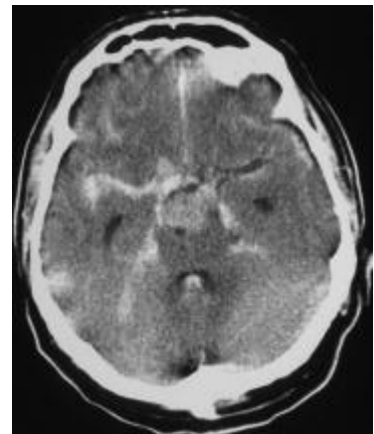
- Engagement
- Hydrocéphalie
- Vasospasmes avec AVC ischémique secondaire
- Troubles électrolytiques (surtout hyponatrémie)

Diagnostic

- CT cérébral
- Si CT cérébral normal et suspicion clinique HSA → PL !
LCR xanthochrome après centrifugation
- Angiographie : visualisation de l'anévrisme

Thérapie

- symptomatique : cō TA, protection voies aériens, ttt de la fièvre et hyperglycémie, antiémétiques, analgésiques, ev ttt antiépileptique
- Opération avec clipping de l'anévrisme, rarement ttt endovasculaire avec coiling
- Prévention des vasospasmes : cō avec doppler transcrânien régulier, éviter hypovolémie, anticalciques (Nimodipin).



Pronostic

- Létalité dépend de la sévérité et de l'âge, en moyen à 30j : 40-50% !

Thrombose veineuse cérébrale

Epidémiologie

- Surtout jeunes femmes
- Incidence annuelle : ~1 / 100'000

Facteurs de risque

- Tabac, contraception orale, néoplasie, thrombophilie héréditaire ou acquise

Clinique

- Céphalées d'apparition sous-aigues
- Déficits neurologiques focaux
- Crise épileptique

Diagnostic

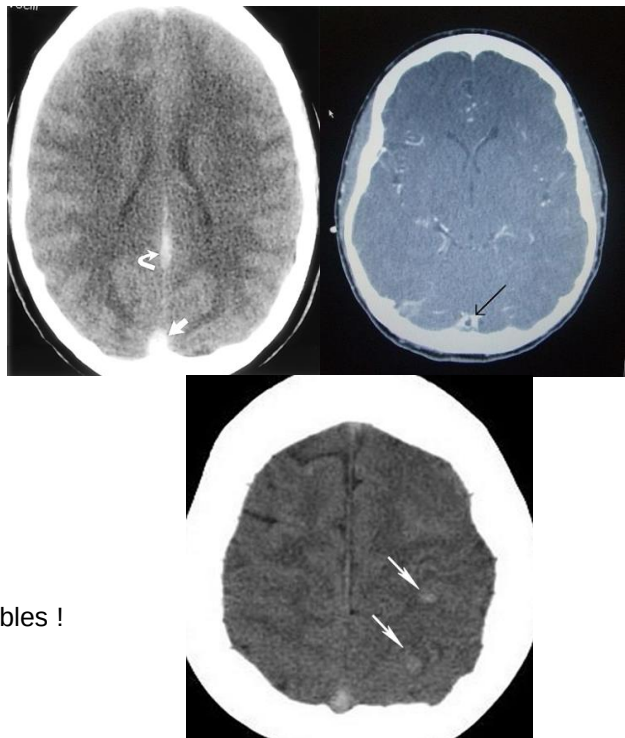
- Angio-CT ou angio-IRM veineux
- ev. angiographie si CT et IRM négatifs
- Labo : D-Dimer, crase spéciale

Thérapie

- Anticoagulation, même si saignements visibles !

Pronostic

- Récupération complète chez ~85% !



Artérite tempore de Horton

Epidémiologie

- Vasculite la plus importante dans le quotidien clinique
- Incidence ~17 / 100'000
- Femmes : Hommes = 2 : 1

Pathogénèse

- Réponse immunitaire à un antigène qui produit une inflammation necrotisante de la paroi de vaisseaux grands et moyens
- Histologiquement infiltration gigantomacrophagaire
- Tous le corps peut être touché, mais l'artère carotide externe semble être la manifestation la plus fréquente

Clinique

- Céphalées oppressifs, diffus ou temporaux
- Symptômes généraux : fatigue, inappétence, perte de poids
- Souvent températures sous-fébriles
- Claudication masticatoire : ischémie du muscle masséter qui produit une péjoration des douleurs lors de la mastication → pauses (20% des patients)
- Artères temporaux douloureux, gonflés, rouges, tordus (50% des patients)
- Amaurose soudaine unilatérale irréversible sur neuropathie optique antérieure ischémique (AION)
- Ischémies cérébraux, surtout avec hémianopsie (rares)

Diagnostic

- Labo : VS > 50/h, CRP
- Sonographie des artères temporaux : signe du « halo »
- Biopsie de l'artère temporale

Thérapie

- Stéroïdes avec sevrage extrêmement lent